Samedi 25: GEU

CAS CLINIQUE : Grossesse Extra-Utérine (GEU)

Énoncé initial

- **Patiente :** Femme âgée de 23 ans.
- **Motif de consultation :** Douleurs pelviennes violentes depuis le petit matin.
- **Antécédents gynécologiques :** Cycle régulier habituellement de 28 jours, mais présente un retard de règles de 14 jours, accompagné de métrorragies peu abondantes.
- **Examen clinique :** Utérus de taille normale, douloureux à la mobilisation.
- **Bilan biologique :**
    - Concentration de β-hCG : 5215 UI/l.
    - Groupe sanguin de la patiente : O rhésus négatif.
    - Groupe sanguin du conjoint : O rhésus positif.
    - Recherche d'Agglutinines Irrégulières (RAI) : négative.

Question 1

Quel diagnostic évoquez-vous en premier lieu ?

- **Réponse :** Une grossesse extra-utérine.

Question 2

Quel est le premier examen paraclinique à faire pour ce diagnostic ?

- **Réponse :** Échographie.

Question 3

Quelles attitudes thérapeutiques sont envisageables ?

- **Réponse :**
    - **Abstention thérapeutique :** non retenue car le taux de β-hCG est élevé (> 1000).

- **Traitement par méthotrexate :** envisageable sous réserve de critères complémentaires échographiques et biologiques (progestérone).
- **Traitement chirurgical :** par cœlioscopie.

Question 4 (Évolution 1)

Événement : La patiente présente un malaise. L'échographie réalisée retrouve un épanchement intra-abdominal de moyenne abondance et une image hétérogène latéro-utérine gauche.
Quelle est votre attitude ?

- **Réponse :**
  - Il s'agit d'un tableau de rupture d'une grossesse extra-utérine.
  - Prise en charge chirurgicale en urgence.

Question 5

Quels sont les facteurs de risques qui doivent être recherchés par l'interrogatoire ?

- **Réponse :**
  - Un antécédent d'infections sexuellement transmissibles (MST/IST).
  - La présence d'un dispositif intra-utérin (DIU).
  - Des antécédents de chirurgie tubaire ou pelvienne (appendicectomie par exemple).
  - Un antécédent d'infertilité et de prise en charge en Assistance Médicale à la Procréation (AMP).
  - Une intoxication tabagique.
  - Un âge maternel élevé.

Question 6

Quels sont les risques de la grossesse extra-utérine à court et à long terme ?

- **Réponse :**
  - Mortalité par hémorragie cataclysmique.
  - Infertilité.
  - Récidive.

Question 7 (Évolution 2)

Événement : Quelques mois plus tard, la patiente se présente pour une nouvelle grossesse. Le résultat de sa RAI est positif.
Qu'en pensez-vous ?

- **Réponse :** Il s'agit d'une allo-immunisation dans le système rhésus pouvant être secondaire à l'absence de prévention par injection de gammaglobulines anti-D au moment de la GEU.